BULLETIN HEBDOMADAIRE · VEILLE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

PAUSE AR

Nouveautés de la semaine du 7 novembre 2026

5 nouveautés cette semaine, dont 2 susceptibles de changer votre pratique.

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION PÉDIATRIQUE Essai randomisé

Perioperative respiratory adverse events in children undergoing adenotonsillectomy with laryngeal mask airway versus endotracheal tube ventilation: multicentre, randomised controlled trial

BMJ · 4 novembre 2026 · Essai randomisé multicentrique

Cet essai a comparé la ventilation au masque laryngé et la ventilation sur sonde d'intubation chez 400 enfants de 2 à moins de 7 ans opérés d'une adéno-amygdalectomie sous anesthésie générale, dans quatre hôpitaux de niveau tertiaire en Chine. Le critère principal, composite, réunissait le laryngospasme, le bronchospasme, la désaturation, l'obstruction des voies aériennes, la toux sévère et le stridor : au moins un de ces événements est survenu chez 22,5 % des enfants ventilés au masque laryngé, contre 57,5 % de ceux ventilés sur sonde, soit une différence absolue de 35,0 points de pourcentage en faveur du masque laryngé. Parmi ces composantes, l'écart le plus large portait sur la toux sévère, puis sur la désaturation ; aucun événement indésirable grave n'a été observé dans l'un ou l'autre groupe. Les auteurs limitent toutefois leur conclusion à une ventilation au masque laryngé assurée par des anesthésistes expérimentés.

> **En pratique :** chez l'enfant de 2 à moins de 7 ans opéré d'une adéno-amygdalectomie, la ventilation au masque laryngé s'accompagne de nettement moins d'événements respiratoires périopératoires que la ventilation sur sonde d'intubation : la différence absolue est de 35,0 points de pourcentage sur un critère composite, et l'avantage se retrouve pendant comme après l'intervention. L'écart est large, mais il repose surtout sur les deux composantes qui montrent les écarts les plus larges, la toux sévère et la désaturation, et il a été obtenu par des anesthésistes expérimentés dans le maniement du masque laryngé au cours de cette chirurgie. C'est un argument pour privilégier le masque laryngé quand l'équipe en a l'habitude, l'essai ne disant rien du risque de complication grave : aucune ne s'est produite dans l'un ou l'autre groupe.

Article original

ANESTHÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE Essai randomisé

Individualized mean arterial pressure during cardiac surgery The OPTIPAM Randomized Clinical Trial

Anesthesiology · 6 novembre 2026 · Essai randomisé multicentrique

Faut-il régler la pression artérielle peropératoire sur la pression habituelle du patient plutôt que sur un seuil commun ? Cet essai a comparé une cible individualisée et une prise en charge standard chez des adultes opérés d'une chirurgie cardiaque programmée sous circulation extracorporelle, dans dix centres tertiaires français. La cible individualisée était une pression artérielle moyenne à plus ou moins 10 % de la valeur de référence mesurée avant l'intervention, maintenue pendant la chirurgie puis 24 heures après ; la prise en charge standard visait une pression artérielle moyenne d'au moins 65 mmHg. Le comité de surveillance a arrêté l'essai après l'inclusion de 172 patients, en raison d'un excès de complications hémorragiques dans le groupe individualisé : 18 % contre 3 %. Sur son critère principal composite, cet essai interrompu ne permet pas de dire si la cible individualisée réduit les complications postopératoires majeures : ce qu'il montre, c'est un excès de complications hémorragiques, signal de tolérance que les auteurs appellent à étudier plus avant.

> **En pratique :** en chirurgie cardiaque programmée sous circulation extracorporelle, viser une pression artérielle moyenne calée sur la valeur préopératoire du patient s'est accompagné de davantage de complications hémorragiques, au point de faire arrêter l'essai : c'est le résultat à retenir, et rien dans cet essai ne vient appuyer l'adoption d'une telle cible. L'essai ne dit rien, en revanche, du bénéfice éventuel d'une telle stratégie sur les complications postopératoires majeures : interrompu et sous-dimensionné, il laisse la question ouverte. Les auteurs demandent que ce signal hémorragique soit étudié avant toute nouvelle évaluation d'une cible individualisée. La pression n'a d'ailleurs été relevée qu'au prix de davantage de vasopresseurs, et pour une cible atteinte un tiers du temps seulement.

Article original

ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE & DOULEUR Essai randomisé · TOPIC-2

Thoracic epidural versus paravertebral blockade for reducing chronic post-thoracotomy pain (TOPIC-2): open label, parallel group, superiority, multicentre, randomised controlled trial

BMJ · 5 novembre 2026 · Essai randomisé multicentrique

Cet essai de supériorité a comparé un bloc paravertébral et une péridurale thoracique chez 737 adultes opérés d'une thoracotomie dans quinze centres britanniques, pour savoir si le bloc prévenait mieux la douleur chronique post-thoracotomie. À six mois, cette douleur touchait 22 % des patients du groupe bloc paravertébral, contre 16 % de ceux du groupe péridurale : la supériorité recherchée n'est pas démontrée, et l'intervalle de confiance reste compatible avec l'absence de différence comme avec un excès de douleur chronique sous bloc paravertébral. La douleur aiguë était un peu plus forte au premier jour sous bloc paravertébral, sans écart retrouvé ensuite, et les effets indésirables ne vont pas tous dans le même sens : moins d'hypotension et moins de prurit avec le bloc paravertébral, mais davantage de rétentions urinaires ; les autres complications étaient comparables. Ces résultats étayent le maintien des deux techniques, sans établir qu'elles se valent sur la douleur chronique.

> **En pratique :** chez l'adulte opéré par thoracotomie, le bloc paravertébral n'a pas réduit l'incidence de la douleur chronique à six mois par rapport à la péridurale thoracique : la supériorité recherchée n'est pas démontrée, et cet essai ne permet pas davantage d'affirmer que les deux techniques se valent sur ce critère. Le choix peut donc continuer de reposer sur le profil d'effets indésirables attendu et sur le terrain du patient : moins d'hypotension et moins de prurit du côté du bloc paravertébral, davantage de rétentions urinaires, et une analgésie un peu meilleure au premier jour du côté de la péridurale. Les deux techniques conservent ainsi chacune leur place après chirurgie thoracique ouverte.

Article original

ARRÊT CARDIAQUE, URGENCES & PRÉ-HOSPITALIER Consensus scientifique international

2026 International Liaison Committee on Resuscitation Consensus on Science With Treatment Recommendations: Summary from the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces

Resuscitation · 5 novembre 2026 · Consensus international, méthode GRADE

L'ILCOR publie la synthèse annuelle de son consensus scientifique international assorti de recommandations thérapeutiques (Consensus on Science With Treatment Recommendations). Après la revue exhaustive achevée en 2025, cette synthèse porte sur les données les plus récemment publiées en réanimation, réexaminées par six groupes de travail : réanimation de base ; réanimation spécialisée ; réanimation pédiatrique ; réanimation du nouveau-né ; formation, mise en œuvre et travail en équipe ; premiers secours. Le niveau de certitude des données y est apprécié selon la méthode GRADE, et les énoncés des groupes s'accompagnent de recommandations thérapeutiques de consensus. Les groupes exposent en outre la façon dont ces recommandations ont été décidées et dressent la liste de leurs priorités de recherche.

> **En pratique :** ce document ne se lit pas comme un protocole : il expose, champ par champ, les données réexaminées cette année, le niveau de certitude qui leur est attribué et la recommandation thérapeutique de consensus qui les accompagne. Le lecteur a intérêt à ouvrir la section du groupe de travail qui correspond à son champ d'exercice et à y lire les énoncés qui touchent à sa pratique. Aucune conduite à tenir ne se déduit de la synthèse prise dans son ensemble : ce sont les énoncés eux-mêmes qui font foi. Les lacunes des connaissances signalées indiquent par ailleurs les points sur lesquels la pratique reste mal étayée.

Article original

HÉMODYNAMIQUE, CHOC & REMPLISSAGE Méta-analyse

Sodium bicarbonate therapy for metabolic acidosis in critically ill patients: a Bayesian systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials

Intensive Care Med · 2 novembre 2026 · Revue systématique et méta-analyse bayésienne

Chez l'adulte de réanimation présentant une acidose métabolique, l'intérêt du bicarbonate de sodium intraveineux reste discuté ; cette revue systématique a réuni quatre essais randomisés, soit 1 544 patients, et mis leurs données en commun selon une approche bayésienne à effets aléatoires. Sur la mortalité à court terme, critère de jugement principal, aucun bénéfice clair ne se dégage et l'estimation reste imprécise : le risque relatif est de 0,94, l'intervalle de crédibilité à 95 % va de 0,73 à 1,22 et la probabilité a posteriori de bénéfice s'établit à 72,1 %. Un effet favorable demeure donc plus crédible qu'un effet délétère, sans être démontré pour autant. Sur un critère secondaire, la mise en route d'une épuration extrarénale a été moins fréquente sous bicarbonate (risque relatif 0,74 ; intervalle de crédibilité à 95 % de 0,59 à 0,98), avec une probabilité a posteriori de bénéfice de 97,2 % ; aucun signal de sécurité n'est ressorti de façon constante.

> **En pratique :** chez l'adulte de réanimation en acidose métabolique, les données randomisées disponibles ne démontrent pas de bénéfice du bicarbonate de sodium sur la survie : l'effet estimé sur la mortalité à court terme est faible et imprécis. Elles rendent en revanche très probable une diminution du recours à l'épuration extrarénale, sur un critère secondaire et sans signal de sécurité identifié de façon constante. Le bicarbonate reste donc un traitement à discuter au cas par cas plutôt qu'à administrer systématiquement, et de nouveaux essais sont nécessaires pour identifier les patients les plus susceptibles d'en tirer bénéfice.

Article original

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.